Le cancer thyroïdien réfractaire

À RETENIR

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés évoluent défavorablement (métastases surtout **pulmonaires et osseuses**).
- **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires à l'iode 131** (sujet âgé, tumeur/métastase volumineuse, tumeur moins bien différenciée).
- 4 critères d'iodoréfractarité : absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré fixation ; dose cumulée **600 mCi** sans rémission.
- Facteurs pronostiques : âge, volume, différenciation, histologie agressive, **avidité FDG**, temps de doublement de la Tg **< 1 an**.
- Chimiothérapie décevante ; thérapie ciblée = gain de survie modeste.
- Surveillance clinique et morphologique (TDM) tous les **3–4 mois** : surveillance active / traitement local / traitement systémique selon l'évolutivité.
- RECIST : réponse partielle **↓ 30 %**, progression **↑ 20 %** (par rapport au nadir) ; lésion cible ≥ **10 mm**, ADP ≥ **15 mm** ; max **5 lésions, 2 par organe**.

I. Définition

- Environ **5–15 %** des cancers thyroïdiens différenciés vont évoluer sur un mode défavorable et devenir **métastatiques**, le plus fréquemment aux poumons et à l'os.
- Il a été montré que **2/3** des cancers métastatiques deviennent **réfractaires** à l'iode 131, en particulier :
  - chez les sujets âgés (> 40 ans) ;
  - en cas de tumeur volumineuse, de métastase volumineuse ;
  - en cas de tumeur moins bien différenciée.

II. Tumeur iodoréfractaire : 4 critères

1. Pas de fixation de l'iode 131 des sites métastatiques au départ (bilan initial) ou en cours de traitement ; ou association de lésions I^+ et non I^+.
2. Présence d'au moins **une lésion métastatique ne fixant pas l'iode**.
3. **Progression tumorale** **12–16 mois** après l'iode, malgré une fixation initiale et un traitement bien entrepris (RECIST : **↑ 20 %** du plus grand axe de la lésion).
4. **Dose cumulée** de **600 mCi** sans signe de rémission.

Facteurs pronostiques

- Âge avancé.
- Volume tumoral.
- Degré de différenciation.
- Avidité au FDG : SUV +++.
- Histologie : à cellules hautes, cylindriques…
- Temps de doublement de la Tg **< 1 an**.

Traitement

- Chimiothérapie : résultat **décevant**.
- Thérapie ciblée : gain de survie **modeste**.

III. Cancer avancé ou agressif

Regroupe plusieurs critères (mot « NADIR » noté en marge) :

- **Critère chirurgical** : maladie non résécable d'emblée.
- **Critère histopathologique** : type histologique agressif.
- **Critère biologique** : si la concentration de Tg fait évoquer une progression métastatique, ou si le cancer est devenu radio-iodo-réfractaire.
- **Critère morphologique** : si la maladie devient métastatique ou localement avancée.
- **Critère clinique** : si la maladie devient cliniquement parlante avec des signes de complication.

IV. Surveillance clinique et morphologique tous les 3–4 mois (TDM)

Profil évolutif	Conduite à tenir
Stable ou lentement évolutive ; petit volume tumoral ; asymptomatique ; pas de risque de complication	**Surveillance active** sous LT4 seule
Oligoprogression ; symptômes ; risque de complication	**Traitement local** : chirurgie si locorégional ; radiothérapie ; électrochimiothérapie
Progression rapide ; gros volume tumoral ; symptômes ; risque de complication	**Traitement systémique** : chimiothérapie ; thérapie ciblée

V. Critères d'évaluation de la réponse

1. Critères RECIST

- Évaluation standardisée de la réponse tumorale des tumeurs solides.
- **Examen baseline** avant traitement (définir les lésions) + **examen de suivi** qui compare les mêmes lésions.
- Catégories : réponse complète ; réponse partielle (**↓ 30 %**) ; progression (**↑ 20 %**, par rapport au **nadir**) ; stable.
- Lésions retenues : lésion solide ≥ **10 mm** ; ADP ≥ **15 mm** ; lésion ostéolytique → meilleure ; maximum **5 lésions** et **2 cibles par organe**.

2. Critères PERCIST

- Basés sur le SUV / SUL → voir mise au point +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle proportion des CDT évolue défavorablement ?	Environ 5–15 % (métastases pulmonaires et osseuses surtout).
2. Quelle proportion des cancers métastatiques devient réfractaire à l'iode 131 ?	2/3.
3. Citez les 4 critères d'iodoréfractarité.	Pas de fixation des métastases ; ≥ 1 lésion non fixante ; progression 12–16 mois après l'iode malgré fixation ; dose cumulée de 600 mCi sans rémission.
4. Quel temps de doublement de la Tg est péjoratif ?	< 1 an.
5. Conduite à tenir devant une oligoprogression symptomatique ?	Traitement local : chirurgie, radiothérapie, électrochimiothérapie.
6. Seuils RECIST de réponse partielle et de progression ?	↓ 30 % ; ↑ 20 % par rapport au nadir.
7. Quelles lésions sont mesurables selon RECIST ?	Lésion solide ≥ 10 mm, ADP ≥ 15 mm ; max 5 lésions et 2 cibles par organe.